

Intervenções de cuidados paliativos em pacientes com demência avançada: uma revisão sistemática

Palliative care interventions in patients with advanced dementia: a systematic review

Intervenciones de cuidados paliativos en pacientes con demencia avanzada: una revisión sistemática

DOI:10.34119/bjhrv7n4-162

Submitted: Jun 26th, 2024

Approved: Jul 16th, 2024

Matheus Juliano Oliveira Maragno

Graduando em Medicina

Instituição: Escola Superior de Ciências da Saúde

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: matheus.maragnoal@escs.edu.br

Erik Heidi Viana Suguieda

Graduando em Medicina

Instituição: Escola Superior de Ciências da Saúde

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: erik.suguiedaal@escs.edu.br

Lilian Silva de França

Mestre em Ciências e Saúde

Instituição: Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES - DF), Hospital Universitário de
Brasília (HUB - EBSERH)

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: dralilian.dra@gmail.com

RESUMO

Introdução: No Brasil, apesar da alta prevalência da demência, há poucos estudos e pouca aplicação de Cuidados Paliativos (CP). **Objetivo:** Trazer uma revisão sistemática sobre os efeitos do CP no contexto da demência avançada. **Método:** A população era humanos, de qualquer gênero, em qualquer ambiente, com diagnóstico de demência avançada. Buscamos intervenções clínicas e não clínicas dentro dos CP e o grupo controle cuidado usual ou outros CP. Os estudos utilizados foram Ensaio Clínicos Randomizados (ECR) escritos em inglês, português e espanhol, publicados nos anos de 2014 até 2023. **Resultados:** Acerca da qualidade de vida, nenhum dos três estudos demonstrou superioridade significativa do braço da intervenção. Sobre o manejo de sintomas, três estudos falharam em apresentar superioridade significativa do braço da intervenção; um estudo demonstrou redução da dor observada; e outro artigo observou maior documentação da dor e maior direcionamento do tratamento por sintomas na intervenção. Dentro do planejamento antecipado de cuidados, três artigos demonstraram resultados significativos, porém conflitantes em relação a diretivas antecipadas. Um artigo demonstrou menos conflitos decisórios e outros dois estudos evidenciaram maior concordância entre objetivos de cuidado no grupo da intervenção. O estudo selecionado sobre

uso de intervenções não paliativas demonstrou resultados divergentes entre intervenções. Discussão: Foram demonstradas evidências na percepção e documentação dos sintomas e direcionamento do tratamento, na redução de conflito decisório, na concordância de objetivos de cuidado, nas diretivas antecipadas e na redução de intervenções não paliativas.

Palavras-chave: cuidados paliativos, demência, ensaios clínicos randomizados.

ABSTRACT

Introduction: In Brazil, despite the high prevalence of dementia, there are few studies and limited application of Palliative Care (PC). **Objective:** To conduct a systematic review on the effects of PC in the context of advanced dementia. **Method:** The population consisted of humans of any gender, in any location, diagnosed with advanced dementia. We searched for clinical and non-clinical interventions within PC, with the control group receiving usual care or other forms of PC. The studies included were Randomized Controlled Trials (RCTs) written in English, Portuguese, and Spanish, published from 2014 to 2023. **Results:** Regarding quality of life, none of the three studies showed significant superiority of the intervention arm. On symptom management, three studies failed to show significant superiority of the intervention arm; one study demonstrated reduction in observed pain; and another article noted increased pain documentation and greater symptom-directed treatment in the intervention. Within advance care planning, three articles showed significant results, but conflicted regarding advance directives. One article showed fewer decisional conflicts, and two studies showed greater agreement on care goals in the intervention group. The selected study on non-palliative interventions showed divergent results among interventions. **Discussion:** Evidence was found in symptom perception and documentation, treatment direction, reduction in decisional conflict, agreement on care goals, advance directives, and reduction in non-palliative interventions.

Keywords: palliative care, dementia, randomized controlled trial.

RESUMEN

Introducción: En Brasil, a pesar de la alta prevalencia de demencia, hay pocos estudios y escasa aplicación de Cuidados Paliativos (CP). **Objetivo:** Realizar una revisión sistemática sobre los efectos del CP en el contexto de la demencia avanzada. **Método:** La población consistió en seres humanos de cualquier género, en cualquier entorno, con diagnóstico de demencia avanzada. Se buscaron intervenciones clínicas y no clínicas dentro de los CP, comparando con un grupo control de cuidado habitual u otros CP. Los estudios incluidos fueron Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECR) escritos en inglés, portugués y español, publicados entre 2014 y 2023. **Resultados:** Respecto a la calidad de vida, ninguno de los tres estudios mostró superioridad significativa del brazo de intervención. En cuanto al manejo de síntomas, tres estudios no demostraron superioridad significativa del brazo de intervención; un estudio mostró reducción del dolor observado; y otro artículo destacó una mayor documentación del dolor y un tratamiento más dirigido a los síntomas en la intervención. En cuanto a la planificación anticipada de cuidados, tres artículos mostraron resultados significativos, aunque hubo conflictos en relación con las directivas anticipadas. Un artículo mostró menos conflictos decisoriales y dos estudios mostraron mayor acuerdo en los objetivos de cuidado en el grupo de intervención. El estudio seleccionado sobre el uso de intervenciones no paliativas mostró resultados divergentes entre las intervenciones. **Discusión:** Se encontraron evidencias en la percepción y documentación de síntomas, dirección del tratamiento, reducción de conflictos decisoriales, acuerdo en objetivos de cuidado, directivas anticipadas y reducción de intervenciones no paliativas.

Palabras clave: cuidados paliativos, demencia, ensayos clínicos aleatorizados.

1 INTRODUÇÃO

Demência, termo correspondente a Transtorno Neurocognitivo Maior, é um agravo crônico, progressivo, sem proposta curativa e com alto grau de morbimortalidade e perda funcional.^{2,6} Estima-se mais de cinquenta milhões de casos atualmente, com expectativa de chegar a cerca de cento e cinquenta milhões até o ano de 2050.^{13,11} Os últimos estágios da doença estão associados a um alto grau de disfunção cognitiva, levando a dependência e maior morbidade, com necessidade progressiva de cuidado e treinamento especializado, sobretudo Cuidados Paliativos.¹²

Cuidados Paliativos (CP) agrupa abordagens com foco na qualidade de vida dos pacientes e da família no enfrentamento de doenças ameaçadoras à vida.¹⁴ O CP é tradicionalmente relacionado a pacientes oncológicos onde tem demonstrando melhora na qualidade de vida e, por vezes, prolongando a longevidade deste grupo.²⁰ Atualmente, a maioria dos adultos que necessitam de cuidados paliativos apresentam agravos crônicos, como doenças cardiovasculares e respiratórias, síndrome da imunodeficiência adquirida, diabetes, doenças renais, bem como a demência avançada.^{14,21}

No Brasil, apesar do aumento na mortalidade pela doença de Alzheimer na última década e do subdiagnóstico da demência,^{16,10} há uma grave falta de capacitação de profissionais no cuidado,¹⁵ bem como escassez de informações e de pesquisas dentro do contexto nacional.⁴ Além disso, há poucos estudos e pouca aplicação de CP, principalmente em pacientes não oncológicos. Os CP ainda estão com disponibilidade limitada para locais com serviços de atenção especializada e para poucas patologias,^{14,19} ainda não estando amplamente disponível para a população em geral, principalmente no contexto do SUS.

A pesquisa tem como objetivo trazer uma revisão sistemática sobre os efeitos dos cuidados paliativos no contexto da demência avançada.

2 METODOLOGIA

2.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:

A estruturação desta Revisão Sistemática foi baseada nas orientações do “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA).

Os participantes eram adultos humanos de qualquer gênero, vivendo em qualquer ambiente (ex.: casa ou hospital), com diagnóstico de demência em estágio avançado, prioritariamente classificados de acordo com ferramentas validadas, como Escala de Deterioração Global (“Global Deterioration Scale [GDS]”) ou Estágio de Avaliação Funcional (“Functional Assessment Staging Tool [FAST]”).

Foram aceitas intervenções clínicas e não clínicas, dentro de cuidados paliativos, voltadas tanto para o paciente quanto para cuidadores/ familiares. Como intervenção comparativa, foram aceitos cuidado usual bem como outro cuidado paliativo.

Como resultados primários, buscamos:

- Qualidade de vida, satisfação e conforto na morte
- Manejo dos sintomas
- Planejamento antecipado de cuidados
- Uso de intervenções não paliativas

Para esta Revisão foram utilizados Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) que abordassem como tema principal Cuidados Paliativos na Demência Avançada. Foram utilizados ECR por apresentarem maior nível de evidência, mesmo que em menor grau quantitativo. Foram aceitos apenas artigos escritos em inglês, português e espanhol, publicados nos anos de 2014 até 2023. Foram excluídos artigos cujo foco de análise não fosse demência avançada, estudos fora do período analisado, em outras línguas, além de editoriais, estudos preliminares e outros desenhos que não ECR.

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA:

Foram utilizadas as seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, COCHRANE e EMBASE. As respectivas interfaces de pesquisa foram Pubmed, BVS, Cochrane Library e Embase, com as seguintes estratégias de busca e retorno total de artigos:

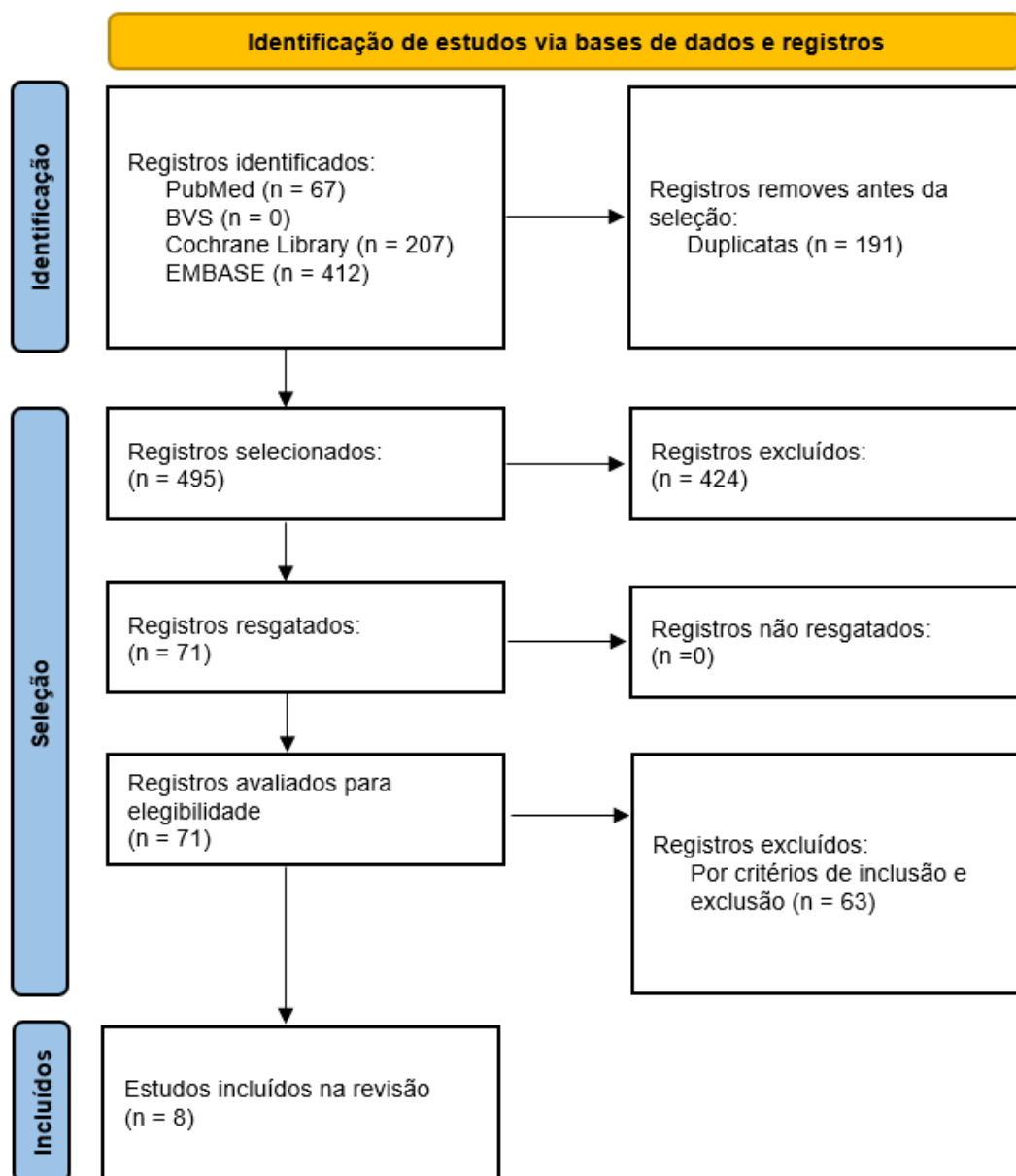
- PubMed: ("Palliative Care"[Mesh] OR "Palliative Medicine"[Mesh] OR "Palliative Care"[tw] OR "Palliative Treatment"[tw] OR "Palliative Therapy"[tw] OR "Palliative

Supportive Care"[tw] OR "Palliative Surgery"[tw] OR "Palliative Medicine"[tw] OR "Palliative Care Medicine"[tw] OR "Palliative*"[tw]) AND ("Dementia"[Mesh] OR "Dementia*"[tw]) AND ("Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Randomized controlled trial*"[tw] OR "RCT"[tw]) AND (2014:2023[pdat]) - 67 artigos;

- BVS: (Palliative Care OR Palliative Medicine OR Palliative Care OR Palliative Treatment OR Palliative Therapy OR Palliative Supportive Care OR Palliative Surgery OR Palliative Medicine OR Palliative Care Medicine OR Palliative\$) AND (Dementia OR Dementia\$) AND (Randomized controlled trial) - 0 artigos;
- COCHRANE: (Palliative Care OR Palliative Medicine OR Palliative Treatment OR Palliative Therapy OR Palliative Surgery OR Palliative*) AND (Dementia*) AND (Randomized Controlled Trial) - 207 artigos;
- EMBASE: ('randomized controlled trial'/syn AND ('palliative therapy'/syn OR 'palliative nursing'/syn OR 'terminal care'/syn) AND 'dementia'/syn AND [2014-2023]/py) - 412 artigos;

A data da última busca foi 15/01/2024, com 686 artigos encontrados e reunidos na plataforma Rayyan. Dois revisores fizeram a seleção inicial, baseada principalmente na leitura do título e do resumo. Nenhum dos revisores possuía acesso às atividades do outro durante esta fase. Um fluxograma foi criado pelo modelo disponibilizado pelo PRISMA.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos.



Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de modelo disponibilizado pelo PRISMA.

3 RESULTADOS

3.1 SELEÇÃO DE ESTUDOS

Foram identificados 686 artigos pela estratégia de busca. Após a remoção das duplicatas, 495 artigos foram analisados com base no título e resumo, sobrando 71 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 13 artigos. Por fim, em leitura de todos artigos na íntegra, foram excluídos 5 estudos, totalizando 8 artigos para a revisão, com espaço

amostral total de 2219 participantes.

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS

Mitchell *et al.* (2021)⁹ foi um ECR em “cluster” para testar a efetividade de uma intervenção multifatorial para manejo de suspeitas de infecções (trato urinário ou respiratório baixo) em residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Os 426 participantes eram pacientes com demência avançada, com GDS >6, nos Estados Unidos (EUA). A intervenção se baseou no treinamento de profissionais e “feedback” sobre melhores práticas em doenças infecciosas, comparado ao grupo controle com cuidados rotineiros. Os resultados avaliados foram quantidade de tratamentos com antimicrobianos, quantidade na ausência de critérios mínimos e procedimentos secundários.

Loizeau *et al.* (2019)⁷ foi um ECR para determinar o impacto de “Fact Box” (ferramentas de apoio) sobre conflito decisório de médicos, de parentes e de tutores de pacientes. Os 232 participantes eram pacientes com demência avançada, na Suíça. A intervenção se baseou em na ferramenta “Fact Box” (2 páginas sobre benefícios e danos de um tratamento), para auxílio na decisão de uso de antibiótico para pneumonia e de hidratação artificial, comparado ao grupo controle. Os resultados analisaram conflitos decisórios, conhecimento e renúncia dos dois tratamentos.

Cohen *et al.* (2019)³ foi ECR em “cluster” para examinar a concordância entre diretivas antecipadas e preferência de cuidado dos representantes de pacientes com demência avançada de ILPI e determinar o impacto de um vídeo sobre planejamento de diretivas antecipadas na concordância. Os 328 participantes eram pacientes com demência avançada, GDS >6, nos EUA. Em entrevistas bases e trimestralmente o grupo da intervenção foi perguntado sobre a preferência no nível de cuidado antes e imediatamente depois de verem um vídeo explicando e exemplificando três níveis de cuidado (“comfort, basic, intensive”). Já o grupo controle foi perguntado apenas uma vez sobre as preferências. Entre resultados relevantes está a concordância das diretivas e das preferências.

Pieper *et al.* (2018)¹⁷ foi ECR em “cluster” para avaliar se a implementação do protocolo “STA OP!” reduziria a dor e melhoraria o seu manejo. Os 288 participantes eram pacientes com demência avançada, GDS 5-7, na Holanda. Houve um treinamento multidisciplinar para aplicação do “STA OP!” para: avaliação da dor e necessidades físicas, avaliação de necessidades voltadas para a demência, tratamentos de conforto não farmacológico e farmacológico e consultar outras disciplinas. Os resultados avaliaram dor estimada e dor

observada.

Mitchell *et al.* (2018)⁸ foi ECR em “cluster” para testar um vídeo sobre Planejamento Antecipado de Cuidados (comparando com cuidado usual) e avaliar os efeitos em diretivas antecipadas documentadas, preferência de nível de cuidado, discussões de objetivos de cuidado e tratamentos desgastantes. Os 402 participantes eram pacientes com demência avançada, GDS >6, nos EUA. Foi aplicado um vídeo para os representantes com comunicação escrita da preferência do nível de cuidado (“comfort, basic, intensive”). Os resultados incluídos foram proporção de não hospitalizar, preferência de conforto, diretrizes para suspender a hidratação intravenosa e de não uso de sonda de alimentação.

Hanson *et al.* (2017)⁵ foi ECR em “cluster” para testar uma intervenção de auxílio à decisão de Metas de Cuidado (“Goals of Care [GOC]”) para melhorar a qualidade de comunicação e cuidados paliativos para residentes de ILPI com demência avançada. Os 302 participantes eram pacientes com demência avançada, GDS 5-7, nos EUA. Foi aplicado um vídeo GOC e uma discussão estruturada com a equipe de cuidados fornecendo informações sobre a demência, objetivos (prolongar a vida, apoiar a função ou melhorar o conforto) e tratamentos consistentes. Resultados incluídos foram a qualidade de comunicação, concordância no objetivo do cuidado e manejo de sintomas.

Agar *et al.* (2017)¹ foi ECR em “cluster” para comparar a eficácia de uma abordagem facilitada para conferência de casos familiares com os cuidados habituais. Os 131 participantes eram pacientes com demência avançada, FAST >5 e AKPS < 50 (“Australia–modified Karnofsky Performance Status”), os quais morreram durante o período de análise em enfermarias na Austrália. Um coordenador de cuidado, treinado em planejamento de cuidados paliativos, ficou responsável por identificar pacientes que se beneficiaram de uma conferência de caso; portanto, organizou o cuidado, entrou contato com a família e orientou os demais profissionais. O resultado avaliado foi aspectos da qualidade de fim de vida e manejo de sintomas.

Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ foi ECR para avaliar o efeito das informações sobre decisões de tratamento para a família do paciente. Os 110 participantes eram pacientes com demência avançada, Escala de Performance Cognitiva 4-6, nos EUA. Reuniões presenciais e por telefone foram realizadas com familiares do grupo da intervenção abordando informações gerais sobre demência, objetivos no cuidado e recomendações para atingir tal objetivo, adentrando os seguintes temas: reanimação, hospitalização, nutrição e hidratação artificiais e manejo da dor e de sintomas. Os resultados avaliados foram a satisfação dos familiares com o cuidado do paciente e seu próprio bem-estar.

3.3 RESULTADOS INDIVIDUAIS

Vide Quadro 1.

Quadro 1. Resultados dos artigos individuais

AUTORES, ANO	PAÍS	OBJETIVOS DO ESTUDO	ORITEM DA POPULAÇÃO E ANO	TAMANHO AMOSTRAL	PRINCIPAIS ACHADOS (RESULTADOS / CONCLUSÃO)
Mitchell et al, 2021	EUA	Testar a efetividade de uma intervenção multicomponentes para melhorar o manejo de suspeitas de ITU e infecções do trato respiratório inferior para residentes de instituições de longa permanência com demência avançada.	Boston, EUA, 2017 a 2020.	426 (199 intervenções / 227 controles)	Apesar da aderência ao treinamento, não houve redução significativa no uso de antibióticos no grupo da intervenção. Houve redução significativa na realização de radiografia torácica.
Loizeau et al, 2019	Suíça	Determinar o impacto de nossas duas recém-desenvolvidas “Fact Boxes” sobre o conflito decisório de médicos, parentes de pacientes com demência e tutores profissionais em decisões relacionadas a antibióticos para pneumonia e hidratação artificial em demência avançada	Região Alemã da Suíça, abril de 2016 a outubro de 2016.	232 (114 intervenções / 118 controles)	Os participantes que receberam a ferramenta demonstraram menos conflito de decisão e maior conhecimento no uso do antibiótico para pneumonia e da hidratação; também maior propensão a renunciar aos antibióticos, porém, não houve diferença na hidratação.
Cohen et al, 2019	EUA	Examinar a concordância entre diretivas avançadas e preferência de cuidado dos representantes de residentes de ILPI com demência avançada e determinar o impacto de um vídeo sobre planejamento de diretivas antecipadas na concordância.	Boston, EUA, fevereiro de 2013 a julho de 2017.	328 (172 intervenções / 156 controles)	Demonstrou resultado significativo, com maior concordância entre as diretrizes e a preferência quando os cuidados de “Conforto” foram analisados separadamente. Contudo, não houve diferença significativa da intervenção e do controle quando os níveis de cuidado foram analisados em conjunto ou quando restritos para cuidados “Intensivos” ou “Básicos”.
Pieper et al, 2018	Holanda	Avaliar se a implementação da intervenção multidisciplinar gradual também reduz a dor e melhora o tratamento da dor	Holanda, janeiro de 2010 a junho de 2012.	288 (148 intervenções / 140 controles)	Mostrou que a prevalência da dor observada (PACSLAC-D) foi maior que a da dor estimada (MDS-RAI). A diferença média ajustada na dor observada (PACSLAC-D) apresentou resultado significativo favorecendo o grupo da intervenção, podendo ser explicado pelo efeito significativo aos 6 meses após a intervenção/implementação. Não houve diferença na escala de estimativa de dor (MDS-RAI) entre os grupos. O braço da intervenção apresentou uma probabilidade significativamente maior de receber opiáceos, mas não de paracetamol ou outros analgésicos.

Mitchell et al, 2018	EUA	Testar se um vídeo sobre planejamento de diretivas avançadas tem efeito em diretivas avançadas documentadas, preferências de nível de cuidado, discussões de objetivos de cuidado, e tratamentos desgastantes em residentes de ILPI com demência avançada.	Boston, EUA, 2013 a 2017	402 (212 intervenções / 190 controles)	As diretivas para não hospitalizar, preferências por cuidados de conforto, as diretrizes para suspender a hidratação intravenosa e os tratamentos onerosos não diferiram entre os grupos. O grupo da intervenção apresentou mais diretivas de não usar sonda de alimentação. Quando os representantes preferiam cuidados de conforto, as diretivas antecipadas dos residentes no braço de intervenção tinham maior probabilidade de se alinhar com essa preferência.
Hanson et al, 2017	EUA	Testar uma intervenção de auxílio à decisão de Metas de Cuidado (GOC) para melhorar a qualidade da comunicação e cuidados paliativos para residentes de lares de idosos com demência avançada.	Califórnia, EUA, abril de 2012 a setembro de 2014.	302 (151 intervenções / 151 controles)	O grupo de intervenção demonstrou melhor comunicação de fim de vida comparado ao controle, apesar de comunicações menos positivas na comunicação geral. O grupo da intervenção apresentou melhor concordância dos objetivos do cuidado no início e no fim do cuidado. O conforto foi progressivamente o objetivo principal dos dois grupos. Não houve diferença nos escores para manejo de sintomas nem satisfação do cuidado.
Agar et al, 2017	Austrália	Compara Conferência de Caso Facilitada (FCC) com Cuidado Usual.	Austrália, fevereiro 2013 a dezembro de 2014.	131 (67 intervenções / 64 controles)	Não houve efeito de grupo significativo para escala de avaliação de conforto na morte (CAD-EOLD), para a escala de satisfação no cuidado (SWC-EOLD) ou para a escala de manejo de sintomas (SM-EOLD). O grupo da intervenção apresentou maior documentação e maior manejo da dor, demonstrando maior frequência de início de medicações orientado pelos sintomas do que por diagnóstico.
Reinhardt et al, 2014	EUA	O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da informação e do apoio fornecidos aos familiares sobre os prós e os contras das decisões de tratamento que podem surgir à medida que aumenta a gravidade da demência do seu familiar.	New York, USA.	110 (58 intervenções / 52 controles)	Os resultados mostraram que as famílias de intervenção tiveram maior satisfação com os cuidados do que as famílias de comparação no período de 6 meses, e eram mais propensas a ter decidido sobre as opções médicas listadas nas diretivas antecipadas dos residentes (Não Reanimar, Intubar, Hospitalizar) ao longo do tempo. Os resultados do estudo reforçam a necessidade de maior educação e apoio às famílias em torno de questões de decisões sobre cuidados de fim de vida para demência avançada. Os resultados não demonstraram efeito significativo no manejo sintomático por grupos ou por tempo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

- **Qualidade de vida, Satisfação e Conforto na morte**

Na análise de qualidade de vida foram incluídos 3 estudos.^{5, 1, 18} O estudo Hanson *et al.* (2017)⁵ não apresentou diferença significativa entre os grupos em nenhum tempo do estudo na escala de satisfação com cuidado (SWC-EOLD). O Agar *et al.* (2017)¹ também não demonstrou efeito significativo nem no SWC-EOLD nem na escala de avaliação de conforto na morte (CAD-EOLD), realizados ou pela família ou pela equipe profissional. No Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ não apresentou diferença significativa entre os grupos na Escala de Satisfação de Cuidado; porém, o grupo da intervenção demonstrou melhor pontuação de forma significativa na Classificação de Cuidado “Single-item” no tempo 3, sem demonstrar diferença em outros tempos do estudo.

- **Manejo dos sintomas**

Na análise do manejo de sintomas foram incluídos 4 estudos.^{17, 5, 1, 18} O estudo Piper *et al.* (2018)¹⁷ apresentou resultado significativo favorecendo o grupo da intervenção na diferença média ajustada na dor observada (PACSLAC-D), podendo ser explicado pelo efeito significativo aos 6 meses após a intervenção/implementação; mas não apresentou diferença na escala de estimativa de dor (MDS-RAI) entre os grupos. Hanson *et al.* (2017)⁵ não apresentou diferença significativa na escala de manejo de sintomas (SM-EOLD) entre os grupos em nenhum tempo do estudo. Agar *et al.* (2017)¹ também não mostrou efeito de grupo significativo na escala SM-EOLD, seja pela família ou seja pela enfermagem. Contudo, no Agar *et al.* (2017)¹ o grupo da intervenção obteve maior documentação de sintomas e mais alterações farmacológicas e não farmacológicas no mês anterior à morte; maior documentação da avaliação da dor; e iniciou medicações mais frequentemente orientadas para os sintomas (ex.: analgésicos) do que para o diagnóstico (ex.: antibióticos). O Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ não demonstrou efeito significativo no manejo sintomático por grupos ou por tempo e também não houve interação significativa em sintomas depressivos ou na escala de satisfação de vida.

- **Planejamento Antecipado de Cuidados e Nível de Cuidado**

Na análise do planejamento antecipado de cuidados foram incluídos 5 estudos,^{8, 5, 18, 7, 3,} 5 três no quesito diretivas antecipadas, um em conflito decisório e dois na concordância de objetivos de cuidado.

Sobre diretivas, no estudo Mitchell *et al.* (2018)⁸ o grupo da intervenção apresentou mais chances de diretivas de não sonda alimentar de forma significativa comparando com o controle, porém diretivas para não hospitalizar (DNH) e para suspensão da hidratação não diferiram entre os grupos; também não apresentou diferenças nos tratamentos invasivos. No

estudo Hanson *et al.* (2017)⁵ diretivas de não ressuscitar (DNR) foram menos comuns no grupo da intervenção, sem diferença nas diretivas sobre sonda alimentar e DNH. O Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ mostrou que o grupo da intervenção foi significativamente mais propenso a adicionar Diretiva de Não Entubar (DNI), DNR, DNH e Diretiva de não Sonda Alimentar; também foi mais propenso a ter “Medical Orders for Life-Sustaining Treatment (MOLST)” adicionado ao prontuário.

Sobre o conflito decisório, no Loizeau *et al.* (2019)⁷ o grupo da intervenção apresentou menos conflitos decisórios sobre uso de antibióticos e sobre hidratação artificial em um mês.

Sobre concordância de objetivos de cuidado, Cohen *et al.* (2019)³ demonstrou resultado significativo, com maior concordância entre as diretrizes e a preferência no grupo da intervenção quando os cuidados de conforto foram analisados separadamente; contudo, não houve diferença significativa quando analisados em conjunto ou quando restritos para cuidados intensivos ou básicos. No Hanson *et al.* (2017)⁵ o grupo da intervenção mostrou significativa superioridade na concordância dos objetivos de cuidados primários por familiares tomadores de decisão na avaliação final (9 meses ou morte).

- **Uso de Intervenções Não Paliativas**

Na análise de uso de intervenções não paliativas foi incluído um artigo.⁹ Mitchell *et al.* (2021)⁹ demonstrou uma redução não significativa no tratamento antimicrobiano de Infecções do Trato Urinário e do Trato Respiratório Inferior por pessoa-ano no braço da intervenção. Também não houve diferença significativa no início de antibióticos sem critérios mínimos, cateterismos vesicais, coleta de sangue venoso e transferências hospitalares. O uso de radiografia de tórax apresentou resultado significativamente menor no braço da intervenção.

4 DISCUSSÃO

4.1 SUMÁRIO DA EVIDÊNCIA

O principal objetivo da revisão sistemática foi avaliar e comparar os efeitos de várias formas dos cuidados paliativos aplicados em pacientes com demência avançada. Oito ensaios clínicos randomizados se encaixaram nos critérios de inclusão, os quais foram analisados e divididos sob quatro aspectos dos cuidados paliativos.

Sobre o ponto de vista da qualidade de vida, satisfação e conforto na morte, Hanson *et al.* (2017)⁵, Agar *et al.* (2017)¹ e Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ utilizaram métodos similares de avaliação (ex.: CAD-EOLD e SWC-EOLD), porém nenhum dos três demonstrou superioridade

significativa dos grupos das intervenções em escalas de satisfação do cuidado ou de conforto na morte. Portanto, as intervenções utilizadas pelos estudos no contexto dos cuidados paliativos não mostraram benefício em relação ao cuidado usual para esses desfechos.

Analisando os resultados dos quatro artigos sob o aspecto do manejo de sintomas, os grupos das intervenções de Hanson *et al.* (2017)⁵, de Agar *et al.* (2017)¹ e de Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ não demonstraram superioridade significativa em relação aos grupos controles. Piper *et al.* (2018)¹⁷ demonstrou redução significativa da dor observada, mas não da dor estimada, o que exhibe a importância de se avaliar a dor sob diferentes perspectivas, possibilitando identificar e manejar a sintomatologia com maior sensibilidade. No Agar *et al.* (2017)¹ foi observado maior documentação da avaliação da dor bem como maior direcionamento do tratamento pelos sintomas e menor pelo diagnóstico, o que está de acordo com os princípios dos cuidados paliativos em individualizar a terapia para a necessidade de cada paciente.

Os cinco artigos analisados sob a perspectiva do planejamento antecipado de cuidados foram avaliados em três subgrupos. Na síntese dentro das diretivas antecipadas, os três artigos revelam resultados significativos, porém com algumas conclusões conflitantes entre si: Reinhardt *et al.* (2014)¹⁸ demonstrou, no braço da intervenção, aumento significativo de DNI, DNR, DNH e de não sonda alimentar; no Mitchell *et al.* (2018)⁸ foi observado aumento significativo de diretivas de não sonda alimentar na intervenção, porém não sobre a DNH ou sobre a hidratação artificial; e no Hanson *et al.* (2017)⁵ foi encontrado significativamente menos DNR no grupo da intervenção, sem diferenças sobre a sonda alimentar e DNH. Tal resultado talvez possa ser explicado pelo fato de os artigos utilizarem diferentes intervenções ou mesmo por diferentes formas de mensuração dos resultados, exibindo uma necessidade de novas observações. De toda forma, fica evidente a necessidade de novos estudos para uma conclusão robusta.

Loizeau *et al.* (2019)⁷ demonstrou menos conflitos decisórios no grupo da intervenção em relação ao controle. Por fim, Cohen *et al.* (2019)³ e Hanson *et al.* (2017)⁵ evidenciaram maior concordância entre os objetivos de cuidado no braço da intervenção. Nessa perspectiva, a aplicação da intervenção demonstrou maior coesão e segurança nos tomadores de decisão nos objetivos de cuidado dos pacientes com demência avançada.

Mitchell *et al.* (2021)⁹, cujo resultado buscado foi o uso de intervenções não paliativas, não exibiu redução significativa no uso de antibióticos no braço da intervenção, mas apresentou redução significativa na realização de radiografia torácica. Assim, levou a uma menor invasão e exposição dos pacientes ao exame, mesmo não apresentando alteração do uso de antibióticos.

Em síntese, todos os oito artigos incluídos demonstraram algum resultado positivo

significativo em favor do grupo de intervenção dos cuidados paliativos dentro dos desfechos estabelecidos. Dois artigos ^{17,1} demonstraram evidências positivas dentro da percepção e documentação dos sintomas e direcionamento do tratamento. Os cinco artigos ^{7, 13, 18, 5, 18} os quais abordaram o planejamento antecipado de cuidados revelaram algum desfecho favorável para a intervenção na redução de conflito decisório, na concordância de objetivos de cuidado e nas diretivas antecipadas, apesar de conflitos no último desfecho. Um artigo ⁹ denotou redução de realização de radiografia no braço da intervenção, sem influência na prescrição antibiótica. Todavia, não foi apontado superioridade dos cuidados paliativos no quesito de Qualidade de Vida, Satisfação no Cuidado e Conforto na morte.

4.2 LIMITAÇÕES

Um achado evidente é a ausência de informação de custo-efetividade e de custo-benefício das intervenções. A ampliação do acesso e a disponibilidade do tratamento depende não só da evidência, mas também da aplicabilidade em um âmbito de saúde pública.

Uma limitação desta Revisão foi o pequeno número de artigos encontrados dentro dos critérios de inclusão estabelecidos. Objetivamos avaliar quatro grupos de resultados dos cuidados paliativos em pacientes com demência avançada a partir de ECR, mas a quantidade reduzida de estudos para cada grupo de desfecho pode ter interferido na conclusão final.

4.3 CONCLUSÕES

Os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas presentes na literatura sobre o tema abordado ainda não são o suficiente para a definição do melhor cuidado dos pacientes. Felizmente, os cuidados paliativos vêm sendo cada vez mais aplicados e estudados em diversas áreas da saúde, apresentando novas evidências. Mais estudos intervencionistas e observacionais são necessários para a apresentação de conclusões sobre a melhor aplicação dos cuidados paliativos.

Um ponto importante a ser considerado é a ausência de estudos no território nacional, ou mesmo em algum país semelhante em características sociodemográficas. A saúde no Brasil é baseada no modelo de seguridade social, portanto, não só características clínicas como também econômicas, sociais e culturais devem ser avaliadas objetivando a aplicabilidade para os grupos com maior necessidade.

Apesar da ampla necessidade da população, os cuidados paliativos ainda têm

acessibilidade restrita no Brasil, necessitando de mais investimentos tanto em estudos na área quanto na disponibilização do serviço no SUS.

Esta pesquisa foi apoiada pelo Programa de Iniciação Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde (PIC/ESCS). Não houve conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. AGAR M. *et al.* *Effects of facilitated family case conferencing for advanced dementia: A cluster randomised clinical trial.* PLoS One. 2017 Aug 7;12(8):e0181020. DOI: 10.1371/journal.pone.0181020. PMID: 28786995; PMCID: PMC5546584.
2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders.* 5th-TR ed. [s.l.] American Psychiatric Association, 2022.
3. COHEN S. M. *et al.* *Concordance Between Proxy Level of Care Preference and Advance Directives Among Nursing Home Residents With Advanced Dementia: A Cluster Randomized Clinical Trial.* J Pain Symptom Manage. 2019 Jan;57(1):37-46.e1. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2018.09.018. Epub 2018 Sep 29. PMID: 30273717; PMCID: PMC6310643.
4. GONÇALVES, E. A. G., CARMO, J.S. *Diagnóstico da doença de Alzheimer na população brasileira: um levantamento bibliográfico.* Revista Psicologia e Saúde [Internet]. 2012 [citado 2021 Jun 15]; (2):170–6. Disponível em: <http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/viewFile/183/271>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.
5. HANSON L. C. *et al.* *Effect of the Goals of Care Intervention for Advanced Dementia: a Randomized Clinical Trial.* JAMA internal medicine 2017; 177(1): 24-31.
6. LEE, M. *et al.* *Dementia and Life Expectancy: What Do We Know?* Journal of the American Medical Directors Association, v. 10, n. 7, p. 466–471, set. 2009.
7. LOIZEAU A. J. *et al.* *Fact Box decision support tools reduce decisional conflict about antibiotics for pneumonia and artificial hydration in advanced dementia: a randomized controlled trial.* Age Ageing. 2019 Jan 1;48(1):67-74. DOI: 10.1093/ageing/afy149. PMID: 30321268; PMCID: PMC6322502.
8. MITCHELL, S. L. *et al.* *An Advance Care Planning Video Decision Support Tool for Nursing Home Residents With Advanced Dementia: A Cluster Randomized Clinical Trial.* JAMA Intern Med. 2018 Jul 1;178(7):961-969. DOI: 10.1001/jamainternmed.2018.1506. PMID: 29868778; PMCID: PMC6033645.
9. MITCHELL, S. L. *et al.* *The Trial to Reduce Antimicrobial Use in Nursing Home Residents With Alzheimer Disease and Other Dementias (TRAIN-AD): A Cluster Randomized Clinical Trial.* JAMA Intern Med. 2021 Sep 1;181(9):1174-1182. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.3098. PMID: 34251396; PMCID: PMC8276127.
10. NAKAMURA, A. E. *et al.* *Dementia underdiagnosis in Brazil.* Lancet [Internet]. 2015 Jan 31;385(9966):418–419. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60153-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60153-2). Acesso em: 29 de abril de 2024.
11. NICHOLS, E. *et al.* *Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.* Lancet Public Health. 2022;7(2):e105–e125. DOI:10.1016/S2468-2667(21)00249-8.

12. OMS - Organização Mundial da Saúde. *Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025*. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789241513487>>. Acesso em: 23 de abril de 2024.
13. OMS - Organização Mundial da Saúde. *Global status report on the public health response to dementia*. Genebra: OMS, 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245>. Acesso em: 23 de abril de 2024.
14. OMS - Organização Mundial da Saúde. *Palliative Care*. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>. Acesso em: 10 de julho de 2024.
15. PARRA, M.A. *et al.* *Dementia in Latin America Assessing the present and envisioning the future*. Neurology. 2018;90(5):222–31. DOI: 10.1212/wnl.00000000000004897.
16. PASCHALIDIS, M. *et al.* *Trends in mortality from Alzheimer's disease in Brazil, 2000-2019*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 32, p. e2022886, 12 maio 2023. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/ress/2023.v32n2/e2022886/pt>. Acesso em: 27 de abril de 2024.
17. PIEPER M. J. C. *et al.* *Effects on pain of a stepwise multidisciplinary intervention (STA OP!) that targets pain and behavior in advanced dementia: A cluster randomized controlled trial*. Palliat Med. 2018 Mar;32(3):682-692. DOI: 10.1177/0269216316689237. Epub 2017 Feb 1. PMID: 28142397.
18. REINHARDT J. P. *et al.* *Vital conversations with family in the nursing home: preparation for end-stage dementia care*. J Soc Work End Life Palliat Care. 2014;10(2):112-26. DOI: 10.1080/15524256.2014.906371. PMID: 24835382.
19. SANTOS, A., FERREIRA, E., GUIRRO, U.. *Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil 2019*. Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2020. Disponível em: https://paliativo.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ATLAS_2019_final_compressed.pdf. Acesso em: 28 de outubro de 2023.
20. TEMEL, J. S. *et al.* *Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer*. The New England journal of medicine, v. 363, n. 8, p. 733–42, 2010.
21. VAN DER STEEN, J. T. *et al.* *White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: A Delphi study and recommendations from the European Association for Palliative Care*. Palliative Medicine, v. 28, n. 3, p. 197–209, 4 jul. 2013.